

Colique néphrétique

Q 014

Diagnostic positif

• DIAGNOSTIC CLINIQUE

➤ Interrogatoire

- Terrain : **Homme** > Femme (S/R : 3-4) entre 20–60 ans (pic entre 30-40 ans)
- Atcd personnel :
 - de coliques néphrétiques
 - d'uropathies et de fdr de lithogénèse :
 - Mie hypercalcémiant (Sarcoidose, hyperparathyroïde, myélome)
 - Goutte
 - Hyperuricémie iatrogène (Chimiothérapie, Aspirine faible dose, ciclosporine, pirilène, thiazidique et furosémide)
- Atcd familiaux
- Signes fonctionnels
 - Douleur brutale, unilatérale, lombaire, irradiant dans l'aîne et les OGE, intense, paroxystique sur fond continu
 - Pas de position antalgique
 - Signes associées :
 - Agitation^Q psychomotrice et anxiété
 - Signes urinaires : hématurie macro, pollakiurie, brûlures mictionnelles^Q : ± témoins d'une irritation vésicale consécutive à un calcul pelvien.
 - Signes digestifs sur iléus réflexe : nausées, vomissements, météorisme^Q, Sd pseudo-occlusif
 - Circonstances favorisantes : Fortes variations du débit urinaire, voyage prolongé, boisson insuffisante, forte chaleur
- Signe négatif : Apyrexie^Q

➤ Examen clinique

- Général : FC, PA, FR, Température, Diurèse +++
- En faveur d'une colique néphrétique
 - Palpation et ébranlement de la fosse lombaire majorant la douleur (**signe de Giordano**)
- Pour éliminer les diagnostics différentiels
 - Palpation et auscultation abdo : Abdomen indolore et souple, sans masse battante et/ou soufflante
 - Examen des orifices herniaires et touchers pelviens : normaux
- Examen clinique renouvelé une fois le patient soulagé
- Bandelette urinaire : hématurie et leucocyturie évocatrice d'une inflammation du tractus, pas de nitrites. Ph acide est en faveur d'un cristaux d'Ac urique.

• BILAN PARACLINIQUE

- Bilan minimum à réaliser
 - Créatininémie (recherche IRA)
 - ECBU si anomalie à la BU
 - Arbre urinaire de face^D (opacité de tonalité calciq en regard du tractus urinaire (taille, topoG, densité), et S.d'iléus)
 - Echo^D vésico-rénale, vessie pleine avec doppler des jets urétéraux
 - Recherche signes indirects : dilatation des cavités pyélocalicielles, Obstruction urétérale par étude comparative des jets urétéraux
 - Recherche signes directs : calcul échogène ou une masse pelvienne
- Forme compliquée
 - NFS-plaq, TP et TCA, groupe ABO-Rh, RAI, 1^{ière} et 2^{ième} détermination
 - Hémoculture et ECBU si fièvre
 - TDM spiralé sans injection si colique néphrétique compliquée (surtt si insuffisant rénal)
 - Rechercher une lithias non visualisée au cours des autres examens morphologiques
 - Rechercher une masse pelvienne
 - Des clichés injectés avec UIV en fin d'examen peuvent être réalisés : uro-TDM
- Si F enceinte + risque fœtal ou maternel : UroIRM ou qq clichés d'UIV (après 1^{er} T) avt prise en charge intervent^{oelle}

- **UIV^D : examen de référence « historique » => réalisé en dehors phase aigue car iode crée une diurèse osmotique.**
 - **Stase en amont du calcul :**
 - Retard de sécrétion / rein muet^Q (arrêt transitoire de sécrétion à phase aiguë, ou par destruction rein si chronique)
 - Retard d'excrétion^Q
 - Hypodensité du pdc en amont
 - **Dans obstruction aiguë**, ± extravasation péri-rénale^Q si rupture voie excrétrice
 - **Dans obstruction chronique**, ± signe du croissant de Dunbar (ligne opaque semicirculaire très fine dessinant la moitié périph des calices) pathognomonique de obstruction avec distension voie excrétrice
 - **Dilatation^Q des cavités en amont**

CALCULS RADIOTRANSARENTS	RADIO-OPAQUES
■ Acide urique^Q ■ Plus rarement xanthine^Q	■ Oxalate de calcium^Q souvent spiculé^Q ■ Phosphate de calcium^Q ■ Phosphoamoniacomagnésien^Q ■ Cystinique^Q

- **SIGNES DE GRAVITE : COLIQUE NEPHRETIQUE COMPLIQUEE => 3 CRITERES D'HOSPITALISATION**

- **Colique néphrétique fébrile > 38°C^Q (ou hypothermie)**
 - ± état septique (frissons, froideur des extrémités,...) => ECBU, HAA, NFS
 - Risque à court terme de choc septique et de destruction du parenchyme rénal
- **Colique néphrétique avec oligo-anurie^Q**
 - Obstruction complète des 2 uretères ou sur un rein unique
 - Risque d'IRA → créatininémie systématique, surveillance régulière de sa diurèse
- **Colique néphrétique hyperalgique**
 - Persistance et/ou répétition des crises douloureuses malgré un ttt antalgique bien conduit
 - Douleur non proportionnelle à la taille du calcul
 - Intervention de drainage de la voie excrétrice à but antalgique
- **Rupture voie excrétrice**

- **TERRAINS A RISQUE**

- **Colique néphrétique chez la femme enceinte**
 - Diagnostic parfois difficile (douleur du flanc absente ds 10 % des cas)
 - signes digestifs et des troubles mictionnels
 - risque d'accouchement prématuré et de rupture prématurée des membranes
- **Colique néphrétique et co-morbidité**
 - Insuffisance rénale chronique
 - Uropathie pré existante
 - Rein transplanté
 - Patient HIV traité par Indinavir®

Diagnostic différentiel

- **Se pose dans les formes atypiques avec**
 - **digestives** (appendicite aiguë, sigmoïdite, colique hépatique, cholécystite, ulcère gastrique)
 - **urologiques** (prostatite, torsion testiculaire, infarctus rénal, tumeur rénale ou des voies urinaires)
 - **gynécologiques** (torsion kyste ovaire, GEU)
 - **vasculaires** (fissuration d'anévrisme, nécrose ischémique du caecum)
 - **Arthrose lombaire, lumbago aigu**
 - **PFLA**

Diagnostic étiologique

➤ Tout obstacle sur la voie excrétrice

- **Lithiase urinaire** : cause la plus fréquente (75-80 %) par ordre décroissant
 - Lithiase calcique : oxalate ou phosphate
 - Lithiase urique
 - Lithiase phospho-ammoniac-magnésienne
 - Lithiase cystinique et xanthique
- **Obstacle non lithiasique**
 - Sd de la **jonction** pyélo-urétérale
 - **Tumeur uroépithéliale** de la voie excrétrice^Q
 - **Sténose** urétérale : post **radique**, **Bilharzienne**, **tuberculeuse**
 - **Nécrose papillaire** aigue (Diabète, drépano, ...)
 - Toutes hématuries avec **caillots** (traumatisme, cancer...) => hématurie précède la douleur

➤ Compression extrinsèque de l'uretère

- **Adp** ilio-obturatrice
- **Tumeur** maligne (utérus, ovaire surtt) ou parfois bénigne (+ rare)
- **Fibrose** rétropéritonéale idiopathique ou secondaire (Méthysergide Désernil®)

CAT en situation d'urgence

• TRAITEMENT DE LA CRISE AIGUE NON COMPLIQUEE

- **Repos au lit**
- **Restriction hydrique^{QD}** : 500 cc/24 h
- **Triade médicamenteuse indispensable**
 - **Antalgiques^D** par voie parentérale (morphinique^Q d'emblée si douleur majeure)
 - **Antispasmodiques^D** par voie parentérale
 - **AINS^{QD}** par voie parentérale en l'absence de CI
 - **non** recommandés dans **grossesse**, CI au **3ème T** de la grossesse, CI si **Ins rénale**
 - Il semblerait que ce soit le **principal traitement actif et indispensable** (protocole Urg-lapeyronie et Uro)
- **Si la crise cède le traitement sera relayé par voie orale en ambulatoire avec**
 - Surveillance de la **température**
 - **Recueil et tamisage des urines**
 - **ECBU et UIV** en externe à distance (place de l'UIV ?)
 - Recommandations écrites données au patient:

I Poursuivez le ttt comme prescrit. Ne modifiez pas les doses sans avis médical.

II Tamisez^D les urines au travers d'un grand filtre à café et conservez tous les calculs expulsés, que vous apporterez lors de la consultation prévue.

III Buvez normalement en répartissant bien les prises au cours de la journée. Mangez normalement.

IV Mesurez votre **température tous les matins**.

V Consultez en urgence en cas de :

- **fièvre** vérifiée, à 38°C ou plus OU si **frissons**
- **vomissements**
- réapparition ou modification de la **douleur**
- **malaise**
- **urines rouges** ou si vous **n'urinez pas pendant 24 heures**.

VI Faites faire les **examens** prescrits comme prévu et apportez les résultats à la consultation.

VII Attention : la **disparition de la douleur ne signifie pas que vous soyez guéri**. Il faut faire les examens et consulter comme prévu dans tous les cas.

- **Si la crise ne cède pas**
 - Hospitalisation avec renouvellement du traitement parentéral
 - Eventuellement associé à un analgésique morphinique
 - Drainage chirurgical des urines est rarement nécessaire

- **EN CAS DE COLIQUE NEPHRETIQUE COMPLIQUEE**

- **Anurie^Q et hyperthermie^Q** st les 2 seules indications à une levée d'obstacle en urgence.
- **Hospitalisation en urgence en Urologie**
- **Prélèvements bactériologiques^D** : hémocultures, ECBU
- **Mise en route d'une bi-antibiothérapie^D parentérale probabiliste en urgence : aminopenicilline + aminoside^D** (ou FQ + aminoside sans attendre les résultats des examens) si fièvre
- **Examens d'imagerie** pour confirmer et localiser l'obstacle
- **Drainage des urines** par **néphrostomie percutanée** ou **montée de sonde urétérale** en urgence en fonction des signes :
 - Infectieux (tolérance de la fièvre, signes de choc)
 - De la douleur (drainage à visée antalgique si hyperalgique)
 - Du terrain
 - De la réponse au traitement
- **Prévenir le Sd de levée d'obstacle par un apport hydrique suffisant après la levée** (risque de DEC^Q) **si anurie**
- **En cas de lithiase > 4 mm, discuter la lithotripsie**

- **A DISTANCE**

- Une **1^{ière} crise** de colique néphrétique, **en** particulier s'il existe un **contexte favorisant** (T°C élevée et boissons insuffisantes) n'implique **pas de bilan métabolique**.
- Dans un autre contexte, on prévoira secondairement un bilan chez un sujet non hospitalisé (dosage du **calcium**, du **phosphore**, de l'**acide urique** et de la **créatinine** dans le sang et dans les urines de 24 heures ainsi qu'une mesure de la bicarbonatémie et de l'urée urinaire des 24 heures).

Sources : Rev Prat, Impact, InternatTest, ANAES 99, Medline d'uro